

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

CUESTIONARIO EUROPEO DE ALFABETIZACIÓN EN SALUD (HLS-EU-Q16)

European Health Literacy Survey (Sørensen et al., 2013, 2015) · Adaptación y Validación en España (Nolasco et al., 2020)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Cuestionario Europeo de Alfabetización en Salud - Forma Corta de 16 Ítems (HLS-EU-Q16)
Sigla / Acrónimo	HLS-EU-Q16
Autoría original	Consortio HLS-EU (Kristine Sørensen, Univ. de Maastricht; Jürgen M. Pelikan, Viena, 2013)
Adaptación en español	Andreu Nolasco, C. Barona, N. Tamayo-Fonseca et al. (2020, Gaceta Sanitaria)
Constructo evaluado	Dificultad autopercebida para acceder, comprender, evaluar y aplicar información relevante sobre salud
Población diana	Población general adulta (≥ 18 años), pacientes en atención primaria y usuarios de servicios sociosanitarios
Tiempo de aplicación	4 a 6 minutos (autoadministrado o mediante entrevista personal o telefónica)
Estructura y formato	16 ítems evaluados en escala de facilidad de 4 opciones, dicotomizados a 0 o 1 para el cómputo final
Condiciones de uso	Acceso abierto para fines clínicos, docentes y de investigación en salud pública no comercial citando la fuente

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La alfabetización en salud (**health literacy**) se define como el conjunto de habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de los individuos para acceder, comprender, juzgar y aplicar información de salud con el fin de tomar decisiones fundamentadas sobre su cuidado, prevención de enfermedades y promoción de la calidad de vida. El modelo integral del Consortio HLS-EU cruza cuatro procesos de procesamiento de la información (acceso, comprensión, procesamiento/evaluación y aplicación) con tres dominios vitales: atención sanitaria médica, prevención de enfermedades y promoción de la salud.

Una alfabetización en salud inadecuada constituye un determinante social clave de las desigualdades sanitarias; se asocia a un uso desproporcionado e ineficiente de los servicios de urgencias, hospitalizaciones evitables, errores graves en la dosificación farmacológica, menor participación en programas de cribado oncológico y un aumento del 50% en la mortalidad general de pacientes ancianos.

3. ESTRUCTURA Y DOMINIOS VITALES DEL HLS-EU-Q16

Dominio HLS-EU	Nº Ítems	Rango	Tareas de Salud y Competencias Evaluadas
1. Atención y Cuidado Médico	7 ítems	0 - 7	Encontrar información sobre síntomas, comprender instrucciones del médico, prospectos de fármacos y seguir prescripciones
2. Prevención de Enfermedades	5 ítems	0 - 5	Entender por qué necesita revisiones de salud, vacunas, cribados preventivos y juzgar la fiabilidad de advertencias en medios
3. Promoción de la Salud	4 ítems	0 - 4	Comprender consejos sobre alimentación sana, actividad física, bienestar mental y cómo hacer de su hogar un entorno más saludable

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN ESPAÑA Y EUROPA

Consistencia interna	Excelente fiabilidad psicométrica; alfa de Cronbach $\alpha = 0.82$ en la validación poblacional española de Nolasco et al. (2020) y $\alpha = 0.90$ en la muestra europea original (Sørensen et al., 2015).
Correlación con HLS-EU-47	Correlación de Spearman prácticamente perfecta ($r = 0.98$) con la versión extensa de 47 ítems, lo que avala su uso como sustituto rápido y fiable.
Ajuste al modelo Rasch	Excelente ajuste métrico según la teoría de respuesta al ítem (modelo de Rasch), confirmando la unidimensionalidad del constructo latente global de alfabetización en salud.
Validez predictiva	Puntuaciones bajas se asocian de forma independiente a menor nivel socioeconómico, peor estado de salud autopercebido (OR = 2.1) y mayor utilización de consultas médicas.
Equivalencia transcultural	Estructura homogénea comprobada en más de 8 países europeos pertenecientes a la red M-POHL auspiciada por la OMS.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Opciones de respuesta	El sujeto valora cada tarea en una escala de 4 puntos: Muy fácil, Fácil, Difícil o Muy difícil (más opción "No sabe / No contesta").
Regla de dicotomización	Siguiendo el manual oficial del Consorcio HLS-EU: • Muy fácil o Fácil = 1 punto (competencia adecuada). • Difícil, Muy difícil o No sabe / No contesta = 0 puntos (barrera de alfabetización).
Puntuación directa total	Suma lineal de las respuestas dicotomizadas. Rango teórico posible: 0 a 16 puntos .
Control de respuestas válidas	Para que la puntuación sea válida, el sujeto debe haber respondido a un mínimo de 14 de los 16 ítems ; si faltan ≥ 3 , la escala se invalida.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Total	Prevalencia Esp.	Nivel de Alfabetización	Implicación en Autocuidado y Seguridad
0 - 8 puntos	Aprox. 12 - 15%	Inadecuada	Severas dificultades para comprender recetas y prospectos. Alto riesgo clínico.
9 - 12 puntos	Aprox. 35 - 40%	Problemática	Comprensión fragmentaria; vulnerable a desinformación y errores de pauta.
13 - 16 puntos	Aprox. 45 - 50%	Suficiente / Excelente	Autonomía plena para navegar el sistema de salud y seguir tratamientos.

PUNTOS DE CORTE Y ACCIONES ASISTENCIALES:

- **Alfabetización Inadecuada o Problemática (≤ 12 puntos):** Abarca aproximadamente a 1 de cada 2 pacientes en España. Exige al equipo de salud aplicar precauciones universales de alfabetización: uso de lenguaje llano, pictogramas explicativos y confirmación mediante la técnica de **teach-back**.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE ADAPTACIÓN COMUNICATIVA EN CONSULTA MÉDICA

Paso 1: Medición con HLS-EU-Q16: Calcular la puntuación total (0 a 16).

Paso 2: Si Alfabetización es Suficiente (13 — 16): Comunicación estándar; facilitar recursos y portales digitales de autocuidado.

Paso 3: Si Alfabetización es Problemática (9 — 12):

- Desterrar el argot médico; limitar la información a 3 mensajes clave por visita.
- Solicitar al paciente que repita con sus propias palabras qué medicamentos debe tomar y cómo ("¿Cómo le explicaría a su cónyuge lo que hemos acordado hoy?").

Paso 4: Si Alfabetización es Inadecuada (0 — 8):

- Protocolo de seguridad reforzado: redactar pautas farmacológicas con códigos de colores o imágenes de soles y lunas.
- Involucrar a un familiar de apoyo o cuidador principal en la explicación de las citas e instrucciones de alta.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Identificación: Paciente varón de 62 años, trabajador de la construcción jubilado con bajo nivel de escolarización formal, diagnosticado de EPOC y fibrilación auricular, que acudió a Urgencias por un episodio de sangrado gingival severo tras duplicar involuntariamente la dosis de acenocumarol (Sintrom).

Evaluación HLS-EU-Q16: Puntuación Total = 5 / 16 (Alfabetización en Salud Inadecuada).

- Ítems problemáticos: Dificultad para entender el prospecto de los medicamentos (0); para entender qué dice el médico en consulta (0); para juzgar cuándo solicitar una segunda opinión (0); para seguir las instrucciones de los análisis (0). Afirmaba tener vergüenza de decir que no entendía las tablas del Sintrom.

Intervención Asistencial: Se instauró un protocolo de comunicación adaptada con la enfermera gestora de casos: simplificación de la hoja de Sintrom con iconos de pastillas partidas de colores y entrenamiento sistemático en técnica de **teach-back**.

Seguimiento a los 6 meses: Cero episodios hemorrágicos ni visitas a urgencias; excelente control del INR en rango terapéutico (2.0 — 3.0) y adquisición de confianza para realizar preguntas activas en sus consultas.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Seguridad del Paciente:

- **Intoxicaciones Farmacológicas Inadvertidas:** Errores críticos al confundir dosis de insulina rápida vs. lenta o anticoagulantes orales en pacientes con $HLS \leq 8$.
- **Vergüenza del Paciente:** Muchos pacientes disimulan asintiendo con la cabeza para no evidenciar su falta de comprensión; indagar siempre activamente.

Diagnóstico Diferencial:

- **Alfabetización en Salud vs. Nivel Educativo:** Pacientes universitarios pueden tener baja alfabetización en salud ante diagnósticos médicos complejos.
- **Déficit Cognitivo Incipiente:** Distinguir la falta de comprensión por baja competencia lectora de fallos atencionales de origen neurodegenerativo.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Nolasco, A., Barona, C., Tamayo-Fonseca, N., Irlés, M. A., Más, R., Tuells, J., & Pereyra-Zamora, P. (2020). Alfabetización en salud: propiedades psicométricas del cuestionario HLS-EU-Q16. *Gaceta Sanitaria*, 34(4), 399-402. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.08.006>
- Sørensen, K., Pelikan, J. M., Röthlin, F., Ganahl, K., Slonska, Z., Doyle, G., et al. (2015). Health literacy in Europe: comparative results of the European Health Literacy Survey (HLS-EU). *European Journal of Public Health*, 25(6), 1053-1058. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv043>
- Sørensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., & Brand, H. (2012). Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. *BMC Public Health*, 12, 80.
- Pelikan, J. M., Röthlin, F., & Ganahl, K. (2014). Measuring comprehensive health literacy in general populations: validation of instrument, indices and scales of the HLS-EU study. *BMC Public Health*, 14, 1-17.